

細胞障害性抗がん薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師	病院薬剤師
☐ 経口抗がん薬・支持療法薬の服用日と残薬の管理 ☐ 他院処方・市販薬・サプリを含めた併用薬の確認 ☐ 服用期間中の電話フォロー(nadir期の発熱・口内炎など) ☐ 副作用をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ ☐ 家庭での曝露対策(粉碎しない・排泄物の扱い)の説明	☐ レジメン監査・投与量計算(体表面積・腎機能・累積投与量) ☐ 前投薬・制吐薬・補液など支持療法の確認 ☐ 抗がん薬の調製と曝露対策、血管外漏出への対応 ☐ 外来化学療法室での副作用説明・セルフケア指導 ☐ お薬手帳へのレジメン情報の記載・薬局への情報提供
病院と共有する情報 レジメン名・投与日 検査値 副作用のGrade 服用状況・残薬	

2 投与量と臓器機能 — 薬局で確認できること

薬剤	病院で確認する値・上限	理由	保険薬局での活用
カルボプラチン	目標AUCと腎機能(カルバート式:AUC×(GFR+25))	GFRの推定方法で投与量が大きく変わる	処方箋の検査値でクレアチニンの推移を確認
シスプラチン	腎機能(CCr)、補液量、Mg補充	腎障害の予防	尿量・むくみ・水分摂取を聴取、NSAIDsの新規処方に注意
ドキシソビシン	累積投与量 500mg/m ² (他のアントラサイクリン系は換算して通算)	超えると心不全のリスクが上昇	治療歴を通算で把握し、息切れ・むくみを聴取
プレオマイシン	総投与量 300mg(力価)	総量に依存して肺線維症のリスク	乾性咳嗽・息切れを聴取
メトトレキサート(大量療法)	血中濃度、尿pH、ホリナート救援	排泄遅延で重篤な副作用	退院後のNSAIDs・PPIの新規処方に注意
イリノテカン	UGT1A1*6/*28の遺伝子多型	ホモ・複合ヘテロで減量を検討	結果を薬歴に記録し、下痢・発熱の指導を強化

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラルシ)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 警告	カペシタビン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定の頻度を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	メトトレキサート 腎排泄の遅延	処方薬 市販薬 NSAIDs・PPI・ST合剤(市販の解熱鎮痛薬も)	MTX濃度↑ → 骨髄抑制・粘膜障害	市販の解熱鎮痛薬の使用も聴取
注意 添付文書 併用注意	イリノテカン CYP3A4阻害	処方薬 アゾール系抗真菌薬	SN-38↑ → 骨髄抑制・下痢↑	他院の抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書 用法・用量	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝・夕の食後に服用するよう指導
確認 服薬指導上の 注意	細胞障害性・抗がん薬全般 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	発熱性好中球減少症の発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前	投与当日～5日	投与後1～2週	次回来局時
「髪は2～3週目から抜け始めることが多いので、ウィッグや帽子を早めに準備しておくとう安心です」 確認: お薬手帳でレジメン・投与日を確認、他院処方・市販薬・サプリの有無 △ 口腔ケア・歯科受診は治療前に済ませておく	「吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲んでください。2～5日目の吐き気にも備えましょう」 確認: 制吐薬の服用状況、水分・食事量(電話フォローで確認) △ 水分がとれない・尿が少ない時は至急連絡	「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずにすぐ病院へ。手洗い・うがいもこまめに」 確認: 電話フォローでnadir期の発熱・口内炎を確認 △ 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診	「手足のしびれや口内炎、食事の状況はいかがですか。前回と比べて教えてください」 確認: しびれ・口内炎をGradeで記録し、トレーシングレポートで共有 △ Grade2以上は処方医へ情報提供